



Corrélation entre les autoanticorps gastriques et le déficit en vitamine B12

N.ABI, A.LASTAB, A.BOURENANE, H. BOUAB.

Service d'immunologie, L'hôpital militaire régionale universitaire de Constantine.

Introduction

La maladie de Biermer est une affection auto-immune caractérisée par une gastrite atrophique avec destruction progressive des cellules pariétales, entraînant une diminution du facteur intrinsèque et une malabsorption de la vitamine B12. Sur le plan immunologique, elle est principalement associée aux anticorps anti-cellules pariétales (APCA) et aux anticorps anti-facteur intrinsèque (anti-FI). Les APCA sont plus sensibles, tandis que les anti-FI sont moins fréquents mais plus spécifiques. L'objectif de notre travail est d'évaluer le profil des APCA et des anti-FI chez des patients présentant une carence en vitamine B12 et étudier leur association avec cette carence dans une cohorte locale.

Matériels et méthodes

Étude rétrospective descriptive menée de janvier 2024 à septembre 2025 au Service d'Immunologie de l'HMRUC, incluant 71 patients présentant une anémie macrocytaire associée à une carence en vitamine B12.

La recherche des APCA et des anti-FI a été réalisée par IFI sur lames EUROPLUS Parietal Cells + Intrinsic Factor (EUROIMMUN®), permettant leur détection simultanée sur BIOCHIP d'estomac de primate pour les APCA et BIOCHIP facteur intrinsèque humain pour les anti-FI. La révélation est réalisée par un conjugué fluorescent et la lecture par microscopie à fluorescence.



Figure 1 : Principe d'immunofluorescence indirecte

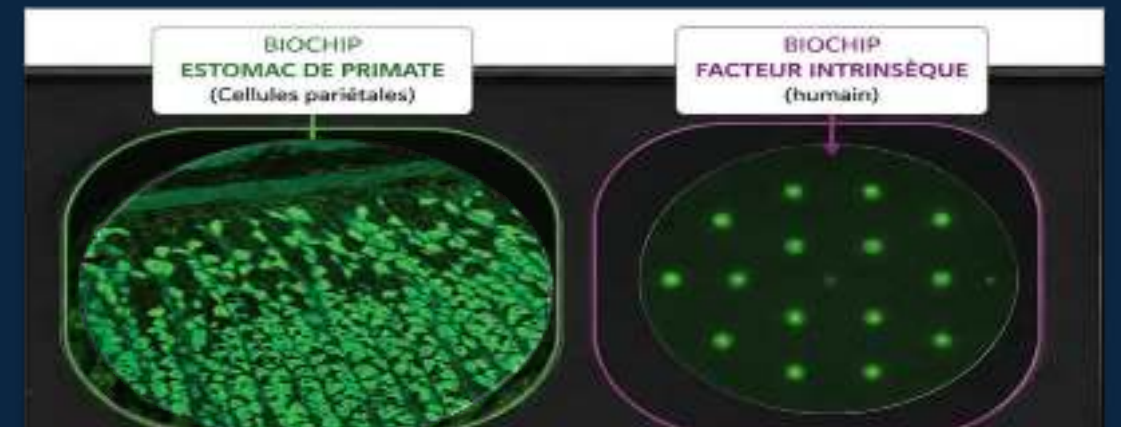
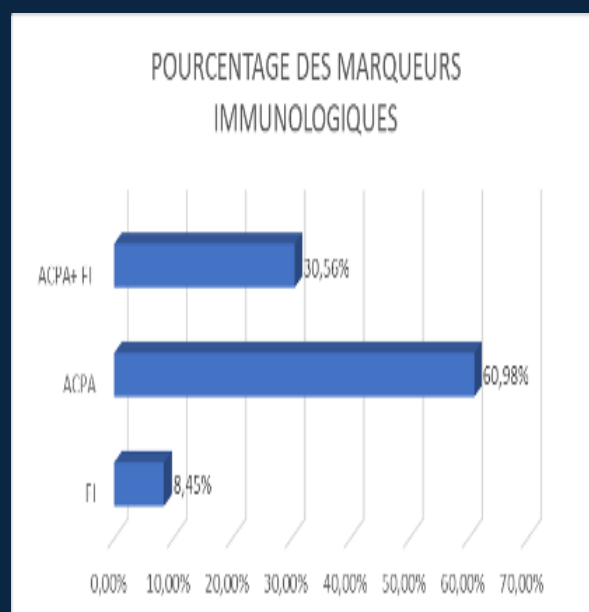
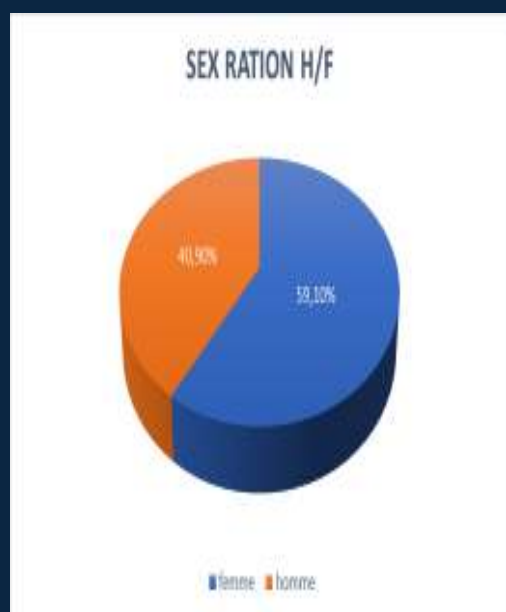


Figure 2 : fluorescence cytoplasmique homogène et diffuse des cellules pariétales.

Figure 3 : fluorescence verte spécifique contenant de FI humain (dots fluorescents).

Résultats

L'âge moyen de la population était de **46,3 ans** [22–82 ans]. Une prédominance masculine était observée, avec **59,1 % d'hommes** et un sex-ratio F/H de **1,44**. Parmi les 71 patients, les **APCA seuls** représentaient le profil sérologique majoritaire (**60,98 %**), suivis de la positivité simultanée des ****APCA et anti-FI (30,56 %)**. Les **anti-FI seuls** étaient retrouvés chez **8,45 %** des patients.



Discussion

Nos résultats confirment la prédominance des APCA dans notre cohorte, en accord avec leur meilleure sensibilité comme marqueur de l'auto-immunité gastrique, tandis que les anti-FI, moins sensibles mais plus spécifiques, apportent une valeur diagnostique complémentaire [1–3]. La réponse auto-immune dirigée contre la H⁺/K⁺-ATPase des cellules pariétales entraîne leur destruction progressive, une atrophie de la muqueuse oxyntique et une diminution du facteur intrinsèque, compromettant ainsi l'absorption de la vitamine B12 [1,2]. La double positivité APCA/anti-FI observée dans 30,56 % des cas souligne l'intérêt d'une recherche combinée de ces deux marqueurs. Cependant, le déficit en vitamine B12 n'est pas exclusivement lié à la maladie de Biermer, d'autres étiologies doivent être envisagées, notamment la gastrite chronique à *Helicobacter pylori*, les gastrectomies ou chirurgies bariatriques, les affections de l'iléon terminal responsables de malabsorption, ainsi que certaines causes nutritionnelles ou médicamenteuses [2,4]. La gastrite à *H. pylori* peut notamment entraîner une atrophie gastrique d'origine inflammatoire non auto-immune et contribuer à la diminution de l'absorption de la cobalamine. Ainsi, la présence d'APCA et/ou d'anti-FI constitue un argument important en faveur d'une origine auto-immune du déficit en vitamine B12, mais leur interprétation doit rester intégrée au contexte clinique et biologique afin de distinguer la maladie de Biermer des autres causes de carence. Lorsque nécessaire, les explorations endoscopiques et histologiques permettent de préciser l'origine de l'atteinte gastrique.

Conclusion

Dans notre cohorte de patients présentant une carence en vitamine B12, les APCA constituaient le profil sérologique prédominant, seuls ou associés aux anti-FI. La recherche combinée des APCA et des anti-FI apporte des informations complémentaires dans l'orientation diagnostique de la maladie de Biermer.

Références

- 1] Tonegato M, Panozzo MP, Antico A, Bizzaro N. Improving the Diagnosis of Autoimmune Gastritis: From Parietal Cell Antibodies to H⁺/K⁺-ATPase Antibodies. *Diagnostics* (Basel). 2024;14(16):1721.
- [2] Shah SC, Piazzuelo MB, Kuipers EJ, Li D. AGA Clinical Practice Update on the Diagnosis and Management of Atrophic Gastritis: Expert Review. *Gastroenterology*. 2021;161(4):1325-1332.e7.
- [3] Krike P, Shums Z, Poljaka I, et al. The Diagnostic Value of Anti-Parietal Cell and Intrinsic Factor Antibodies, Pepsinogens, and Gastrin-17 in Corpus-Restricted Atrophic Gastritis. *Diagnostics* (Basel). 2022;12(11):2784.
- [4] Pour H. *pylori*, je te recommande de vérifier précisément la référence Zhang et al. (2024) avant de l'insérer, car plusieurs publications de 2024 portent sur *H. pylori* et l'atrophie gastrique. Je ne mettrais pas « Zhang et al., 2024 » sans la référence bibliographique exacte.